

糖尿病并发症

糖尿病并发症

应急处理

临床表现

并发症

病因

预控

1. 补液：纠正失水
2. 皮下/静脉使用胰岛素
3. 纠正电解质紊乱
4. 纠正酸中毒
5. 去除诱因和治疗并发症
6. 监护、吸氧
7. 加强基础护理
8. 心理护理

糖尿病酮症酸中毒

胰岛素不足和升糖技术不当升高引起的糖、脂肪、蛋白质代谢紊乱

健康的生活方式和良好的血糖控制是预防的关键

1. 补液：纠正脱水
2. 小剂量胰岛素静脉治疗控制血糖
3. 纠正水、电解质和酸碱失衡
4. 去除诱因和治疗并发症
5. 必要时可行连续性肾脏替代治疗

高渗性高血糖状态

胰岛素缺乏导致高血糖形成高渗透压产生高渗状态

糖尿病患者其他疾病如心梗、脑卒中和手术时应注意监测血糖电解质变化，避免诱因。

1. 意识清醒者口服 15-20 克糖类食品
2. 识障碍者予 50%葡萄糖 20-40ml 静注/胰高糖素 0.5-1.0mg 肌注
3. 每 15 分钟监测 1 次血糖，若血糖<3.9mmol/L 再次葡萄糖口服/静注；血糖>3.9mmol/L，但距下一餐 1h 以上是予含淀粉/蛋白质食物；血糖<3.9mmol/L，继续予 50%葡萄糖 60 毫升静注
7. 低血糖纠正后了解原因调整用药实施相关教育
8. 低血糖为纠正则继续静注葡萄糖，意识恢复后至少监测 24-48h

1. 制定个体化血糖控制目标
2. 加强血糖监测
3. 合理使用可增加低血糖风险的药物
4. 重视低血糖预防教育

1. 血压控制目标个体化
2. 根据动脉粥样硬化性心血管疾病风险等级高低将 LDL-C 降至目标值
3. 应用阿司匹林作为二级预防
4. 联合抗凝和抗血小板治疗减少心血管缺血事件

心血管疾病

糖尿病是 CVD 主要的独立危险因素，与糖化血红蛋白水平呈正相关

1. 血压控制在小于 130/80mmol/L
2. 血脂在目标值内
3. 抗血小板治疗

1. 改变不良生活方式
2. 营养干预
3. 控制血糖、血压、血脂
4. 使用非甾体类盐皮质激素受体拮抗剂
5. CKD 相关并发症评估及肾脏替代治疗

糖尿病肾病

糖尿病所致的慢性肾脏病，病变累及全肾

1. 根据肾病进展风险分层进行相应频率随访
2. 出现 CKD4-5 期治疗效果不佳/非糖尿病所致 CKD/有其他相关并发症时应及时转诊
3.

1. 健康教育，DR 早防早治
2. 控制代谢紊乱
3. 针对 DR 进行内科治疗：如改善微循环
4. 眼科治疗：激光光凝术

糖尿病视网膜病变

糖尿病视网膜微血管病变

1. 定期眼病筛查
2. 血糖、血压、血脂达标
3. 及时转诊是预防失明的主要环节

1. 针对病因及发病机制治疗
2. 疼痛管理：药物/非药物治疗
3. DAN 治疗：停用/减量加重直立性低血压的药物，充分饮水，高钠饮食

糖尿病神经病变

病因尚未完全明确，目前认为主要与高血糖、脂代谢紊乱、胰岛素信号通路异常导致有关

1. 戒烟及血糖、血压、血脂、体重等良好的代谢管理是预防糖尿病神经病变发生的重要措施。
2. 定期进行神经病变的筛查及评估，重视足部护理

1. 明确严重肢体缺血
2. 可行血运重建者行影像学检查择期行血运重建
3. 不可行血运重建者病灶和疼痛稳定的可药物、脊髓刺激/干细胞移植治疗；疼痛不可耐受、感染扩散者截肢

糖尿病下肢动脉病变

1. 动脉粥样硬化与血栓形成
2. 动脉炎和栓塞等

1. LEAD 知识教育
2. 抗血小板治疗
3. 降低心血管事件发生及死亡率、缓解疼痛、促进溃疡愈合、保肢、改善生活质量

1. 评估 DFU 性质加强护理
2. 合理降糖降压调脂和抗血小板治疗
3. 积极治疗糖尿病性 LEAD
4. 合理选择抗生素治疗
5. 合理进行 DFU 局部处理
6. 重视足溃疡减压治疗
7. 辅助使用物理治疗
8. 手术治疗
9. 技术及时会诊与转诊

不同程度周围血管病变

1. 定期识别有风险足
2. DF 知识教育
3. 指导穿合适的鞋具
4. 危险因素/前兆病变的治疗